

REUMATO

code, Tardillo, Rodiles, Colun

- Cuales articulaciones son las **MENOS** afectadas en la artritis psoriásicas?
- Averigua por **marcadores y mediadores** que se manifiestan en la **miopatías inflamatorias** de forma general. Tipo hay una pregunta que tenía una opción que decía aldolasa sérica y en un apunte dice que es la enzima que más se eleva pero NI IDEA. Además de CPK que es obvio que va a elevarse en todas las miopatías (menos la amiopática) fíjate que se elevan LDH, transaminasas, etc
- La polimialgia reumática pertenece a las vasculitis de Takayasu? No, es de la temporal
- Saberse que enfermedades dan **ANA +** y **-**, **FR +Y -**.
- Fármacos que predisponen a osteoporosis:
- Criterios diagnósticos de gota (exactos):demonstarr cristales de URM en leucocitos de liquido sinovial y en tofo bipsiado o aspirado, antecedentes de monoartritis con periodo intercritico asintomático, hiperuricemia persistente y rápida resp a colchicina
- **Fisiopatología de la fibromialgia (exacta)**

NEUMO

- Espirometría: hay 3 criterios que se tienen que tener en cuenta para saber si una espirometría está bien hecha. Dentro del criterio "aceptabilidad" tenes que saber todas las características: Ej: volumen extrapolado **menor a 5% FVC o 150 ml**, etc.
- BODE
- Espirometría de **ASMA y EPOC**
- Identificar la **estructura/vaso sanguíneo** marcada con flecha en la TAC.
- Crisis asmática: identificar si es **leve, moderada, grave y** su tratamiento
- Identificar escalón de **ASMA/GINA**, tratamiento para cada escalón.
- Reducción de tratamiento para el asma en un paciente bien controlado: **dosis o porcentaje y tiempo.**>> ICS 25-50% en **intervalo de 2-3 meses**
- Patrón de **baja densidad en rx** (acertar la patología)
- Que patología se ve mejor en la espiración en radiografía. Respuesta: **neumotórax**
- Saber el TNM completo: tipo además de la aprenderte la N solo sabete también los valores de "T"
- Rarísimo lo siguiente que preguntó en el final: el marcador **CA125** a que estirpe histológica se asocia más? Respuesta: **adenocarcinoma**
- Saber signos directos de bronquiectasias: **dilataicon bronquial índice broncoart> 1, signo anillo de sello, signo de rail de tranvía, signo de ristra de perlas, quistes arracimados, falta de afinamiento bronquial > 2cm, bronquio a menos de 1cm de pleura**
- Que tiene peor pronóstico a 5 años: Cáncer de pulmón o una "no fibrosis pulmonar idiopática"? FPI??
- HPBM está indicada o contraindicada en pacientes com ERC? Actúa sobre factor Xa de la coagulación? **DE ELECCION EN IR**, : actúan sobre **factor Xa** (medir a las 4hs) efecto de 24hs una vez suspendido

- Puede no armarse el block neumónico (consolidación) en: leucopenia, deshidratación, obesos y enfermedad pulmonar crónica.
- Saberse: Efectos adversos, de b2 agonistas (taquicardia, temblor, hipokalemia, aumento de consumo de O₂), LAMA (boca seca, sabor metálico, glaucoma agudo, aumentado riesgo de CV con ipatropio).
- SAMA y LAMA, cual actúa en M2 y M3 o ambos: sama tbn bloquea M2, LAMA disociación rápida al M2
 -] Atenuación en tac
 - [] Grado gold ABE
 - [] Grado disnea
 - [] Rx tx **espiración**
 - [] Imagen tac vasos tórax
 - [] BODE letra por letra
 - [] Eosinofilia en epoc: agregar ICS
 - [] LAMA tiene unión más prolongada al m3 con disociación más rápido del m2, prolongando el efecto BD
 - [] Lama **da sabor metálico, glaucoma agudo, riesgo de eventos CV**
 - [] Bordetella da tos ferina (se los llama quintas) son **emetizantes** y predominan **por la noche**
 - [] Step 4 es **2 cada 12hs** diario, step 3 es **1 cada 12hs**
 - [] Tipos de exacerbación de asma (tipo 1,2,3) **1 más frecuente en mujeres** (ma lenta. Eosinofílica, inflamatoria), la tipo 2 es **obst rápida mas en hombres, broncoespasmos,**
 - [] Crisis asmática metodos compl: **gases sangre y espirometria rx tx**
 - [] **Electrocardiograma fue inventado antes que la espirometria**
 - [] Que mide la espirometria (**tamaño de pulmón y calibre de bronquios**)
 - [] CI de espirometria: **iam reciente, cirugía reciente, embarazo, neumotorax, aneurismas, traqueotomía, demencia, incontinencia**
 - [] HNF vida media corta, **inhibe acoagulante con protamina**
 - [] **Bivalirudina:** se usa si pte tiene **IRgrave**
 - [] Ex físico en EPI
 - [] Clasif de neumonías intersticiales idiopaticas (+ común es FPI)

ENDÓCRINO

- Gigantismo: **además de acromegalia, facie grotesca y visceromegalia que** manifestaciones más da.
- Cuál de estas 4 patologías cursa con ACTH bajo: respuesta: **ingesta de corticoides exógenos.** enfermedad Adisson, Enfermedad de Cushing y feocromocitoma.

- Saber que eje hormonal es indispensable y como se reemplazan en orden de frecuencia.
- Saberse tirotoxicosis con hipertiroidismo y sin hipertiroidismo. En cuales se usa el **iodo 131**. *no se usa en la tirotoxicosis*
- Mecanismo de acción de los GLP1 (la correcta es que retrasan el vaciamiento gástrico entre varias funciones)
- SGLT2 beneficios: el cardiovascular.
- Paciente con diabetes que orina 1200 mg de proteínas al día y a la semana tiene 1100 mg. Saber que clase de nefropatía es: clínica, establecida, es un estadio de ERC...? No la entendí muy bien a esta.
- NEM1 y NEM tipo 2.
- Que evalúa la clasificación de bethesda
- Caso clínico con ejes alterados saber cuál está alterado y si hay panhipopituitarismo
- Alteración fisiológica de hiperprolactinemia
- Saber en qué grupo (NEM 1 o los otros) está la dbt tipo 1
- - [] Caso clínico hipoT sub clínico y clínico saber diferencia
- - [] Nódulo tiroides: saber si SIEMPRE se hace paaf?, saber si en todo nódulo se hace eco, método de screening (ni idea)
- - [] Tirotoxicosis, nódulo autónomo (plummer) bocio multinodular tóxico, se trata con iodo 131
- - [] Característica de patología tiroidea con centellograma frio
- - [] Clasif de Bethesda
- - [] Mecanismo de acción glp1
- - [] Función renal y dbt
- - [] Manifestaciones clínicas de gigantismo
- - [] Que da Acth bajo: ingesta corticoides exógenos
- - [] Beneficios del SGLT2: cardiovascular
- - [] Fisiopato de tiroiditis
- - [] Criterios qx bariátrica
- - [] Causas de dbt secundaria
- - [] Tipos de insulina y vida media
- - [] Complicaciones micro y macrovasculares